

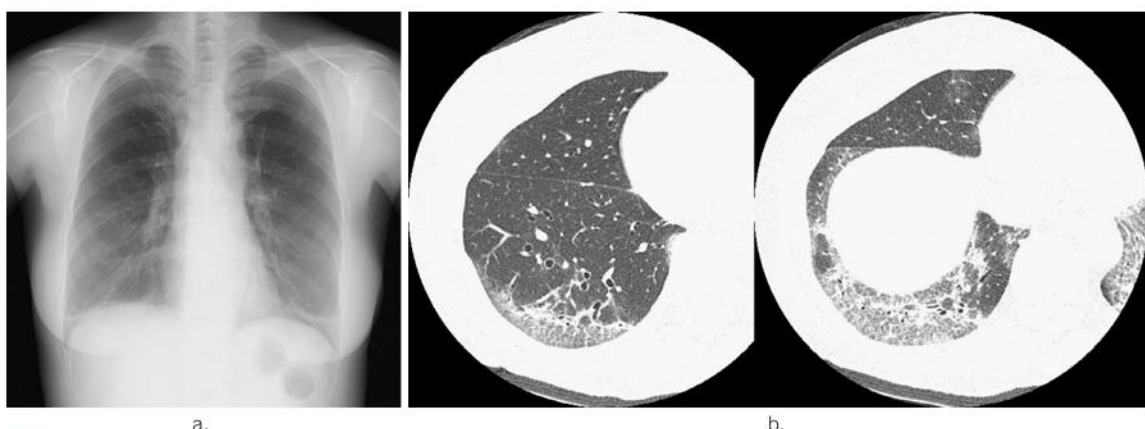


図5 fibrotic NSIP 画像所見

a: 胸部X線写真。下肺野優位にびまん性のすりガラス陰影、網状陰影を認める。b: 胸部HRCT。下葉背側優位に細かな網状影と重なるすりガラス陰影がみられ、変化は均一である。胸膜から離れた内部には気管支血管束に沿う網状影がみられ、牽引性気管支拡張を伴う。

現に注意を払わなければならない。

b 疫学

NSIPの診断には外科的肺生検が必要であることから、現在の診断分類基準における正確なNSIPの頻度は不明である。海外からは、IPF 284例に対してNSIP 66例⁸⁾、本邦の外科的肺生検例の研究ではIPF 200例に対してNSIP 44例（IIPs全体の9%）と報告されている⁹⁾。平均年齢は50歳前後とIPFと比較して10歳程度若い、男女比は約3:7で女性に多く、非喫煙者が6~7割を占める。

症候・身体所見

咳嗽、労作時呼吸困難などの症状が、慢性経過あるいは亜急性の経過でみられる。捻髪音（fine crackles）を聴取することが多いが、パチ指はIPFと比較して頻度が低い。関節痛・関節腫脹、Raynaud現象、皮疹、筋肉痛、口腔内乾燥、ドライアイなどの膠原病様の症状・徴候が10%前後にみられる¹⁰⁾。

検査・診断

他の間質性肺炎と同様にKL-6、SP-Dなどのマーカーの上昇、拘束性換気障害・拡散能障害がみられる。IPFとの鑑別が特に重要であるが、NSIPではIPFと異なり、CRPの上昇、赤沈の亢進などの炎症所見がみられることがある。また、抗核抗体（10~57%）、リウマチ因子（10~33%）などが陽性となることが多い²⁾。

BAL液はIPFと比較してリンパ球比率の上昇（30~60%）を認めるが、リンパ球比率の上昇しないNSIPもしばしばみられる²⁾。

胸部単純X線写真では両側下肺野優位にすりガラス影や浸潤影、網状影がみられ、容積減少を伴うことが多い。典型的なHRCT像は、両側肺底部優位に、

すりガラス陰影・浸潤影・網状影が認められ、容積減少・牽引性気管支拡張を伴う（図5）。IPFとは異なり、所見が肺全体において均一であり、二次小葉内でも均一な所見を示す。典型的な蜂窩肺はみられず、しばしば気管支血管束に沿って病変が分布し、胸膜下には変化が乏しい（subpleural sparing）。気腫の合併例・進行した症例は、IPFとの鑑別が難しい。

気管支鏡検査による病理学的診断は困難であり、外科的肺生検が必要となる。病変は胸膜側から肺内側にかけて比較的均一、びまん性に分布し、小葉内でも同様の広がりを示し、比較的一様で時相が揃っていることが特徴であり、正常肺泡は介在しない（図6）。cellular NSIPでは、肺の基本構造は比較的保たれ、肺胞壁などの間質にリンパ球主体の炎症細胞浸潤がみられ、ポリープ状器質化が腔内に多くない程度にみられる。fibrotic NSIPでは、肺胞壁などの間質に膠原線維の増生がみられ、間質はびまん性に肥厚する。特発性肺線維症と異なり、平滑筋の増生、線維芽細胞巣、蜂窩肺はみられることがあっても程度は強くない。病変分布がNSIPパターンを病理学的に示しても、呼吸細気管支・肺泡道に肉芽腫形成がみられる症例は過敏性肺炎を、間質に胚中心を伴うリンパ濾胞が目立つ症例は膠原病肺である可能性が高くなる。

呼吸器・放射線・病理専門医によるMDDによる診断が必要である。膠原病肺・過敏性肺炎・薬剤性肺炎などの二次性の間質性肺炎の除外、IIPsの中では、IPF、cryptogenic organizing pneumonia（COP）、alveolar macrophage pneumonia（AMP、旧DIP：desquamative interstitial pneumonia）との鑑別が必要となる。膠原病肺との鑑別でいえば、肺外の全身の症候や自己抗体が陽性でありながらも、各膠原病の診断基準を満たさない症例群が存在する。それらはIIPsの中で、interstitial pneumonia with autoimmune fea-